

Guiado

Lista de questões com gabarito e comentários.

QUESTÃO 1 · INEP

Uma paciente com 40 anos, branca, encaminhada da unidade básica de saúde, é atendida para investigação de trombose venosa profunda (TVP). Conta que apresentou um segundo episódio de TVP do membro inferior esquerdo há 30 dias. Informa que faz uso de anticoncepcional oral desde os 18 anos e que a primeira TVP ocorreu aos 36 anos, quando foi tratada com varfarina por 6 meses, sem intercorrências. Conta que teve 3 gestações, a primeira delas, aos 22 anos, resultou em um aborto espontâneo, as outras 2 foram a termo. Ela informa ainda que sua mãe também já apresentou TVP. Relata também que atualmente vem fazendo uso de rivaroxabana. Para investigação de TVP na paciente nesse momento, deve-se solicitar

1. **A)** anticorpos anti-beta-2 glicoproteína 1 IgG e IgM.
2. **B)** anticorpos anticardiolipina IgG e IgM.
3. **C)** proteína C e proteína S livre.
4. **D)** PCR para fator V Leiden.

Gabarito: D — Resposta correta — D. Em paciente usando rivaroxabana, ensaios funcionais de coagulação podem sofrer interferência. A pesquisa molecular por PCR da mutação fator V Leiden não é alterada pelo anticoagulante e é apropriada para investigar trombofilia hereditária diante de TVP recorrente e história familiar. Distratores: A — Incorreta. Anti-beta-2-glicoproteína I integra investigação de síndrome antifosfolípide, mas um único aborto precoce não cumpre critério obstétrico e o quadro familiar sugere trombofilia hereditária. B — Incorreta. Anticardiolipina também pesquisa SAF, devendo ser solicitada segundo probabilidade clínica e confirmada em persistência; não é a melhor resposta isolada aqui. C — Incorreta. Dosagens de proteína C e S podem ser influenciadas por anticoagulação, evento trombótico agudo e outras condições, devendo ser programadas no momento apropriado. Ressalva técnica — anticoncepcional combinado é importante fator provocador e deve ser suspenso. A necessidade e amplitude de testes de trombofilia devem ser individualizadas, pois nem todo resultado muda a duração da anticoagulação.

QUESTÃO 2 · REVALIDA INEP 2026.1

Tratamento da sífilis na gestação Tratamento das parcerias sexuais Mulher, 22 anos, gestante de 8 semanas, realiza teste rápido para sífilis na Unidade Básica de Saúde, com resultado reagente. Nega sintomas ou lesões genitais e demonstra preocupação sobre como informar ao parceiro, com quem mantém relacionamento estável há cerca de 1 ano. Relata relações sexuais atuais com outras parcerias e questiona a necessidade de tratá-las. Além do aconselhamento pós-teste, qual é o manejo adequado para a essa situação?

1. **A)** Tratar a gestante e entregar a prescrição das parcerias, as quais serão comunicadas do diagnóstico por ela.
2. **B)** Tratar a gestante e oferecer apoio à convocação das parcerias para iniciar o tratamento.
3. **C)** Solicitar VDRL da gestante para confirmação do diagnóstico e oferecer apoio à convocação das parcerias para avaliação diagnóstica.
4. **D)** Solicitar FTA-Abs da gestante e das parcerias para a confirmação do diagnóstico.

Gabarito: B

QUESTÃO 3 · REVALIDA INEP 2024.1

Conjuntivite Gonocócica Um recém-nascido, com peso de nascimento de 2.900 g, nascido a termo e de parto vaginal, é levado à primeira consulta pós-natal na unidade básica de saúde com 10 dias de vida. Durante a consulta, observa-se abundante quantidade de secreção purulenta em ambos os olhos da criança e, segundo a mãe, essa secreção teve início há 2 dias, formando-se rapidamente, mesmo após a limpeza. O paciente apresenta, também, hiperemia ocular e edema bipalpebral. Sabe-se que a mãe iniciou tardiamente o pré-natal e fez acompanhamento irregular, e ela refere que, atualmente, está apresentando leucorreia purulenta. O médico, então, solicita swab da secreção, cujo resultado chegará em até 5 dias. Com base nessas informações, quais são, respectivamente, o diagnóstico da doença da criança e a conduta médica adequada para o caso?

1. **A)** Conjuntivite gonocócica; tratar a criança com colírio antibiótico após receber o resultado do swab, já que não há risco de perda da visão.
2. **B)** Conjuntivite bacteriana; orientar a mãe do paciente, realizar limpeza dos olhos e iniciar o uso do colírio antibiótico, mesmo sem o resultado do swab.
3. **C)** Conjuntivite bacteriana; orientar a mãe do paciente, realizar limpeza dos olhos e aguardar o resultado do swab para prescrever colírio antibiótico específico.
4. **D)** Conjuntivite gonocócica; iniciar, mesmo sem o resultado do swab, o tratamento com colírio antibiótico e com ceftriaxona IM, já que há risco de perda da visão.

Gabarito: D

QUESTÃO 4 · REVALIDA INEP 2025.2

Risco Relativo RR Razão de Riscos A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) está preocupada com o aumento de casos de hipertensão arterial entre adultos jovens na comunidade. Então, decide realizar um estudo observacional para investigar se o sedentarismo está associado ao aumento do risco de hipertensão nessa população. O estudo dividiu os participantes em dois grupos, sedentários e não sedentários, e acompanhou esses dois grupos por 12 meses para observar o surgimento de novos casos de hipertensão. Ao final do estudo, é identificado o risco relativo (RR) de 0,6. Nesse estudo, o valor do RR permite inferir que

1. **A)** o sedentarismo pode ser um fator protetor para o desenvolvimento da hipertensão.
2. **B)** a prevalência da doença pode ser avaliada, sem possibilidades de associação dos fatores.
3. **C)** os sedentários têm maior risco de desenvolver hipertensão em comparação com os não sedentários.
4. **D)** o desenho do estudo em questão não permite o uso do RR para avaliar associação entre as variáveis.

Gabarito: A

QUESTÃO 5 · INEP

Um lactente com 3 meses comparece a uma consulta na unidade de saúde da família por mover os olhos de um lado para outro de forma anormal e repetitiva. A mãe do paciente informa que o teste do olhinho, realizado anteriormente, foi inconclusivo e que o bebê recebeu alta sem orientações. A gestação e o parto foram sem intercorrências. Ao exame físico, o lactente apresenta-se eutrófico, com o movimento dos globos oculares oscilatórios, sem a presença de outras alterações neurológicas ou motoras. Com base nessas informações, quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta médica adequada para esse caso?

1. **A)** Catarata congênita; refazer o teste do olhinho no paciente.
2. **B)** Estrabismo; tranquilizar a mãe do paciente e agendar retorno precoce.
3. **C)** Nistagmo; encaminhar o paciente ao oftalmologista e ao neuropediatra.
4. **D)** Xeroftalmia; solicitar dosagem de vitamina A do paciente com urgência.

Gabarito: C

QUESTÃO 6 · INEP

Uma paciente com 40 anos identificou nódulo em região cervical anterior. Ao exame físico, palpa-se nódulo lrm, de cerca de 1 cm, em região cervical anterior e móvel à deglutição. Foram solicitados exames de função tireoidiana, que indicaram normalidade, e ultrassonografia, que mostrou nódulo sólido de 1,3 cm em lobo esquerdo da tireoide. Realizada punção aspirativa com agulha fina, o exame citopatológico mostrou lesão de classificação Bethesda V. Nesse caso, qual é a conduta mais adequada?

1. **A)** Encaminhar para cirurgia da tireoide.
2. **B)** Repetir punção aspirativa com agulha fina.
3. **C)** Solicitar cintilografia de tireoide com Iodo 131.
4. **D)** Realizar ultrassonografia a cada 6 meses para acompanhamento.

Gabarito: A — Resposta correta — A. Bethesda V significa suspeito para malignidade, com risco suficientemente alto para indicar encaminhamento cirúrgico. A extensão da operação depende do tamanho, ultrassom, linfonodos, fatores de risco e preferência, mas simples observação não é adequada. Distratores: B — Incorreta. Repetir PAAF pode atrasar tratamento e não elimina o alto risco já demonstrado. C — Incorreta. Cintilografia é útil quando TSH está suprimido para identificar nódulo hiperfuncionante; função tireoidiana é normal e citologia já é suspeita. D — Incorreta. Vigilância semestral é reservada a nódulos de baixo risco/benignos, não Bethesda V.

QUESTÃO 7 · INEP

Adolescente de 13 anos, sexo masculino, em seguimento na unidade básica de saúde desde os 3 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus desde os 6 anos de idade, foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve duas internações nos últimos três meses por cetoacidose diabética. Durante a consulta, o paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o “deixam gordo” e ele estava “cansado de tomar picada”, desprezando a dose após a manipulação dela. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando, com isso, grande descontentamento do paciente. No que diz respeito ao Código de Ética Médica, o médico

1. **A)** cometeu uma infração, por não respeitar o sigilo médico.
2. **B)** não cometeu uma infração, por ser uma situação de risco.
3. **C)** não cometeu uma infração, por a mãe já saber das internações.
4. **D)** cometeu uma infração, por não respeitar a autonomia do paciente.

Gabarito: B — Resposta correta — B. Embora adolescentes capazes tenham direito à confidencialidade, o sigilo pode ser rompido quando sua manutenção cria risco relevante à vida ou à saúde. Descartar insulina após duas internações recentes por cetoacidose configura risco grave; comunicar a responsável na medida necessária à proteção não constitui infração ética. Distratores: A — Incorreta. O sigilo não é absoluto diante de risco significativo, devendo-se explicar ao adolescente os motivos e preservar o máximo possível de confidencialidade. C — Incorreta. A justificativa não é a mãe conhecer internações anteriores, mas o risco atual causado pela omissão deliberada do tratamento. D — Incorreta. Autonomia deve ser respeitada conforme capacidade, mas não impede intervenção protetiva proporcional diante de risco grave e evitável.

QUESTÃO 8 · INEP

Uma menina de 6 anos em tratamento para leucemia linfóide aguda, é levada a uma unidade de pronto-atendimento infantil devido a pico febril de 38,5°C, sem outros sintomas associados. Ela utiliza um cateter de longa permanência para a administração de quimioterapia, realizada há uma semana. Seu exame físico não revela alterações. Diante do quadro clínico apresentado, assinale a opção correta em relação à propedêutica.

1. **A)** A paciente deve ser tratada com antibióticos de largo espectro, sendo indicada a troca imediata do cateter de longa permanência.
2. **B)** A paciente dispensa a propedêutica complementar, por se tratar de um primeiro pico febril e por não haver alterações no exame físico que indiquem foco infeccioso.
3. **C)** A paciente apresenta alto risco para neutropenia febril e, por isso, deve realizar hemograma, hemocultura de sangue periférico e de cateter central e provas inflamatórias.
4. **D)** A paciente deve realizar hemograma completo e, caso o resultado indique neutrófilos $< 1\,000/\text{mm}^3$, a investigação deve prosseguir com hemocultura, com provas inflamatórias e com hemocultura de cateter central.

Gabarito: C — Resposta correta — C. Febre única de 38,5 °C em criança em quimioterapia e com cateter central deve ser tratada como possível neutropenia febril até prova em contrário. É necessário hemograma, hemocultura periférica e de cada lúmen do cateter e marcadores/avaliação inflamatória, iniciando antibiótico empírico rapidamente conforme neutropenia e risco. Distratores: A — Incorreta. Antibiótico precoce pode ser necessário, mas troca imediata do cateter não é rotina sem suspeita específica de infecção relacionada e avaliação de culturas. B — Incorreta. Ausência de foco físico não exclui bacteremia em neutropenia; investigação é obrigatória. D — Incorreta. Não se deve esperar o resultado do hemograma para colher culturas e iniciar avaliação de febre em paciente oncológica; a abordagem é imediata. Ressalva técnica — a classificação formal de neutropenia e a escolha antibiótica dependem do hemograma e do protocolo institucional, mas a propedêutica não deve ser adiada.

QUESTÃO 9 · REVALIDA INEP 2023.1

Contraindicações Os métodos contraceptivos hormonais femininos combinados são seguros e eficazes, porém devem ser prescritos por um médico ou profissional da saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar e que avalie se a paciente tem alguma contraindicação a esse uso. Segundo a OMS, com relação aos critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos orais combinados, categoria 4, assinale a opção correta.

1. **A)** Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de cefaleia tensional.
2. **B)** Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de trombofilia conhecida.
3. **C)** Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis, como no caso de presença de câncer de mama.
4. **D)** Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis, como nos casos de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar atual ou progressa.

Gabarito: B

QUESTÃO 10 · INEP

Em um distrito sanitário especial indígena, um médico atende a uma criança com 4 anos, com 23 kg, que apresenta taquipneia, tosse, letargia, choro sem lágrimas e febre de 39,2 °C. Como tratamento, o paciente tem utilizado emplastos de ervas no peito. Diante desse quadro, após a avaliação do paciente, o médico precisa, por meio de intérprete, solicitar à mãe que

1. **A)** conceda autorização para internar a criança mantendo os emplastos utilizados.
2. **B)** retire os emplastos e inicie medicamento parenteral em regime de internação para a melhora do desconforto da criança.
3. **C)** realize o tratamento em domicílio com ervas tradicionais de seu povo e que retorne em 7 dias.
4. **D)** inicie uso de antibiótico em domicílio, com visitas da equipe médica, e que mantenha o uso do emplastro.

Gabarito: A — Resposta correta — A. Taquipneia, febre alta, letargia e sinais de desidratação indicam doença grave e necessidade de internação. A equipe deve explicar e obter autorização por meio de intérprete, respeitando prática tradicional inofensiva — os emplastos — desde que não interfira no tratamento biomédico necessário. Distratores: B — Incorreta. Retirar obrigatoriamente uma prática sem evidência de dano desrespeita autonomia e competência intercultural. C — Incorreta. Tratamento domiciliar isolado e retorno em sete dias são inseguros diante de sinais de gravidade. D — Incorreta. Antibiótico domiciliar não oferece monitorização e suporte necessários para criança letárgica, febril e desidratada.

QUESTÃO 11 · REVALIDA INEP 2023.2

Infectologia Uma menina de 6 anos em tratamento para leucemia linfóide aguda, é levada a uma unidade de pronto-atendimento infantil devido a pico febril de 38,5°C, sem outros sintomas associados. Ela utiliza um cateter de longa permanência para a administração de quimioterapia, realizada há uma semana. Seu exame físico não revela alterações. Diante do quadro clínico apresentado, assinale a opção correta em relação à propedêutica.

1. **A)** A paciente deve ser tratada com antibióticos de largo espectro, sendo indicada a troca imediata do cateter de longa permanência.
2. **B)** A paciente dispensa a propedêutica complementar, por se tratar de um primeiro pico febril e por não haver alterações no exame físico que indiquem foco infeccioso.
3. **C)** A paciente apresenta alto risco para neutropenia febril e, por isso, deve realizar hemograma, hemocultura de sangue periférico e de cateter central e provas inflamatórias.
4. **D)** A paciente deve realizar hemograma completo e, caso o resultado indique neutrófilos $< 1\,000/\text{mm}^3$, a investigação deve prosseguir com hemocultura, com provas inflamatórias e com hemocultura de cateter central.

Gabarito: C

QUESTÃO 12 · INEP

Adolescente de 12 anos, sexo feminino, é levada à Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar se suas vacinas estão atualizadas. Até os 8 anos, todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para o biênio 2024-2025 foram feitas, sendo que tomou 1 dose da vacina contra febre amarela aos 9 meses. Nesse momento, deve receber as vacinas

1. **A)** HPV, reforço da hepatite B e dT.
2. **B)** reforço da hepatite B, dT e SCR.
3. **C)** HPV, meningocócica ACWY e febre amarela.
4. **D)** SCR, meningocócica ACWY e febre amarela.

Gabarito: C — Resposta correta — C. Aos 12 anos, com esquema infantil completo até os 8 anos, a adolescente deve receber HPV, meningocócica ACWY e completar a febre amarela porque recebeu a primeira dose aos 9 meses, mas não o reforço previsto aos 4 anos no calendário considerado pela questão. HPV é recomendado nessa faixa etária e a MenACWY é indicada entre 11 e 14 anos. Distratores: A — Incorreta. Não há indicação de reforço rotineiro de hepatite B para quem completou adequadamente o esquema, e a dT depende do intervalo desde a última dose do componente tetânico, não sendo a combinação esperada no caso. B — Incorreta. Hepatite B e tríplice viral não precisam ser repetidas se o esquema anterior está completo; além disso, a alternativa omite HPV e MenACWY. D — Incorreta. A tríplice viral já está completa segundo o enunciado, enquanto a adolescente ainda tem indicação de HPV.